EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL	: HOSPITAL HERMINDA MARTIN	N° EGRESO	: 95278
SERVICIO	: NEUROLOGIA ADULTO HHM	HC	: 2021602688
FECHA	: 21-10-2024	CTA. CTE.	: 857797867
		CP.	: 606308

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARIA MERCEDES ACUÑA MIRANDA			**RUN**	: 8.030.429-3
F.Nac	: 15-01-1956	**Edad**	: 68 AÑOS, 9 MESES	**Género**	: Femenino
Dirección	: EL SAUCE			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA A	**Teléfono**	: 950596905		
Fecha Ingreso	: 2024-10-20	**Fecha Egreso**	: 21-10-2024	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: DERIVACIÓN OTRO ESTABLECIMIENTO EN RED	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I67.1-ANEURISMA CEREBRAL, SIN RUPTURA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

ACV menor derecho vs CIT, probable
ITU alta?
Aneurisma cerebral silviano derecho no roto
DM2
HTA

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I63.3-INFARTO CEREBRAL DEBIDO A TROMBOSIS DE ARTERIAS CEREBRALES (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I67.1-ANEURISMA CEREBRAL, SIN RUPTURA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I15-HIPERTENSION SECUNDARIA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. N39.0-INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Rankin 0. HTA,DM2, antec Ca mama op, ca colon op, QT. El 19/10/24 se describe presenta inestabilidad, disartria, desorientación y debilidad Braquicrural izquierda (se describe NIHSS 3). PA 100/60, FC 60 x min. Consulta en H San Carlos. TC Encefalo sin lesiones agudas. AngioTC cerebro y cuello 19/10/24 Aneurisma sacular polilobulado de la bifurcación de arteria cerebral media derecha (M1 a M2), de orientación anterosuperior y que mide 11 x 9 mm. No hay signos de una hemorragia aguda intracraneana. Signos de displasia muscular de la media en ambas arterias carótidas internas cervicales. Se deriva a HHM Chillan. Evaluado por Neurocirujano sin indicacion quirurgica actual. Ingresa a UTAC. En HSC febriculas, OC inflamatoria, parametros inflamatorios altos, ingresó con tendencia a hipotensión. Se administran 2 dosis de ceftriaxona ev. Evoluciona estable en hemodinamia, sin focalidad neurologica, afebril, pero con aumento de pcr y leucocitosis. Se decide mantener estudio y enfoque como sospecha de evento cerebrovascular transitorio. Por cuadro infeccioso activo con requerimiento de ATB ev (pcr sobre 300) se solicita traslado a su hospital para continuar manejo.

PLAN DE MANEJO:

manejo de lo infaccioso en HSC, control ambul NLy NCX

INDICACIONES AL ALTA

1. Traslado a Hospital San Carlos
2. Reposo relativo
3. Regimen diabetico hiposodico
4. aspirina 100 mg día vo
5. atorvastatina 80 mg dia vo
6. famotidina 40 mg dia vo
7. Ceftriaxona 2 gr ev (dia 2)
8. Urocultivo , Rx de tórax
9. Retomar resto de tratamientos crónicos habiltuales
10. Tramirar Holter de ECG, Ecocardiograma tt (puede ser ambulatorio)
11. Control CAE neurología (de preferencia HSC) 10 dias aprox
12. Control poli Neurocirugía (coordinar con secretaría para cupo con Dr. Correa autorizado por él)

EXÁMENES Y RESULTADOS

TAC Cerebro: 19/10/24 sin lesiones agudas
Angio TAC Cuello y Cerebro: 19/10/24 Aneurisma sacular polilobulado de la bifurcación de arteria cerebral media derecha (M1 a M2), de orientación anterosuperior y que mide 11 x 9 mm. No hay signos de una hemorragia aguda intracraneana. Signos de displasia muscular de la media en ambas arterias carótidas internas cervicales.
ECG Troponinas: Sin FA
Lab Gral: 19/10/24 Glicemia : 142 Creatinina : 1,40 Calcio : 8,2 * mg/dL 8,4 - 10,2 Fosfatasa Alcalina : 262 * U/L 38 - 126 Bilirrubina Indirecta : 0,19 mg/dL < 1,10 Bilirrubina Directa : 0,51 * mg/dL < 0,30 Bilirrubina Total : 0,70 mg/dL 0,20 - 1,30 ASAT/GOT : 126 * U/L 14 - 36 ALAT/GPT : 36 * U/L < 35 Gama GT : 174 * U/L 12 - 43 Clearence Calculado(MDRD) : 37,39 Lactato : 0,9 Proteina C Reactiva : 179,1 Sodio (Na) : 137,00 Potasio (K) : 4,60 Cloro (Cl) : 101,00 Troponina : 5,4 Recuento de leucocitos : 18,30 Hemoglobina : 9,7

Control en: 10 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

Miguel Rivera Matus de la Parra
MEDICO TRATANTE
14210838-0

JEFE SERVICIO